

Douleur pelvienne

- Douleur survenant dans la région abdominale basse, en dessous de l'ombilic
- Douleur aigüe
- Douleur aigüe récidivante (cycliques)
- Douleur chronique

Vignettes cliniques

AA: patiente de 23 ans en BSH, se présente aux urgences pour des douleurs apparues soudainement en FID au lever du lit.

A.gyn: Nulligeste. Ménarche à 13 ans, cycles réguliers, contraception locale par préservatifs, DDR: 17 jours

AP: Tabac: nihil, OH: occasionnel
Asthme allergique traité, Médics: Ventolin en R. Pas d'opération abdo.

A Fam: Mère ca. ovaires à 62 ans
Père: ca. pulmonaire

Status: TA: 160/80 Puls: 94 rég
Temp: 36,7 °C

Abdomen tendu avec défense et détente en FID.

Spec: col sp, TV: masse annexielle D douloureuse

AA: patiente de 47 ans connue pour un utérus multimyomateux avec hyperménorrhée se présente aux urgences avec une douleur pelvienne apparue progressivement depuis 2 jours, actuellement à 8/10.

A.gyn: 4G-3P, 3 AVB, 1FC. Cycles irréguliers de 24-40 jours. DDR: 35 jours

AP: Myomectomie par Pfannenstiel.

A Fam: ca du sein chez la mère à 57 ans

Status: TA: 140/90 Puls: 76 rég Temp: 37,2 °C

Abdomen tendu, douloureux à la palpation de l'utérus Spéculum: col de MP avec léger écoulement de sang foncé, TV: utérus augmenté de volume, irrégulier et douloureux

Contexte/anamnèse

- Puberté, période génitale active, périménopause, ménopause
- Grossesse
- Syndrome inflammatoire/infectieux
- Pathologie gynécologique (ou autre) connue

Diagnostic différentiel

- Complication d'une grossesse débutante:
 - Grossesse intra-utérine
 - Menace de fausse-couche
 - Fausse couche (abortus)
 - complète, incomplète, septique, hémorragique
 - Rétroversion enclavée
 - Etirement du muscle utérin ou des ligaments
 - Grossesse extra-utérine (ectopique)
 - Tubaire
 - Cornuale
 - Cicatricielle

Contexte inflammatoire/infectieux

- Pelvic inflammatory disease (PID)
 - Annexite
 - Abscès tubo-ovarien
- Endométrite (souvent au décours d'une intervention)
 - IVG (interruption de grossesse)
 - FC (abortus)
 - HSG (hystéro-salpingographie)
 - AVB (accouchement par voie basse), C/S (césarienne)

Diagnostic différentiel

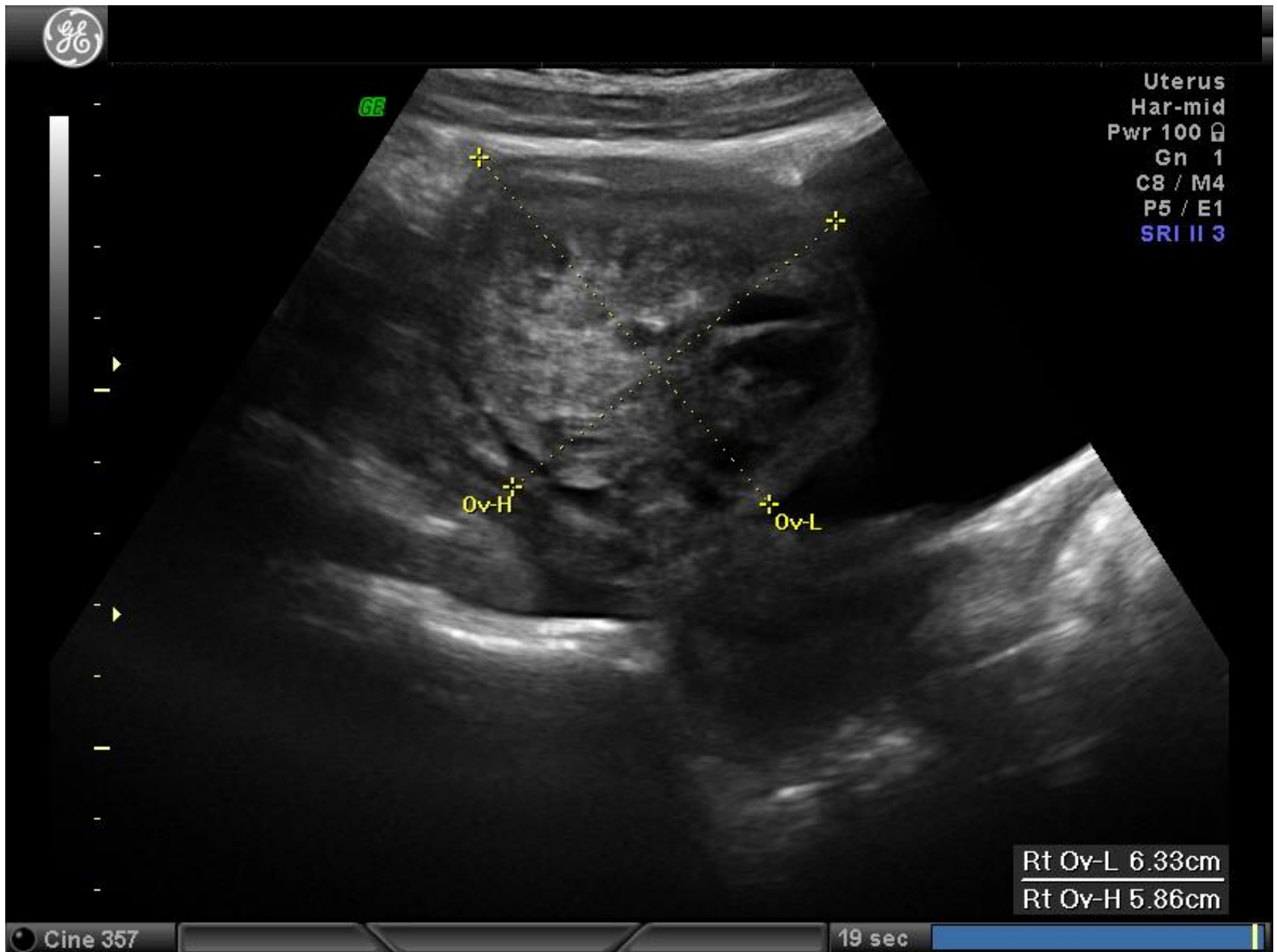
- Complication d'une pathologie gynécologique
 - Myome: nécrose, torsion, expulsion
 - Kyste ovarien (fonctionnel ou organique):
 - rupture
 - torsion ovarienne/annexielle
- Endométriose
- Cancer
 - Ovaires, col , endomètre

Diagnostic différentiel?

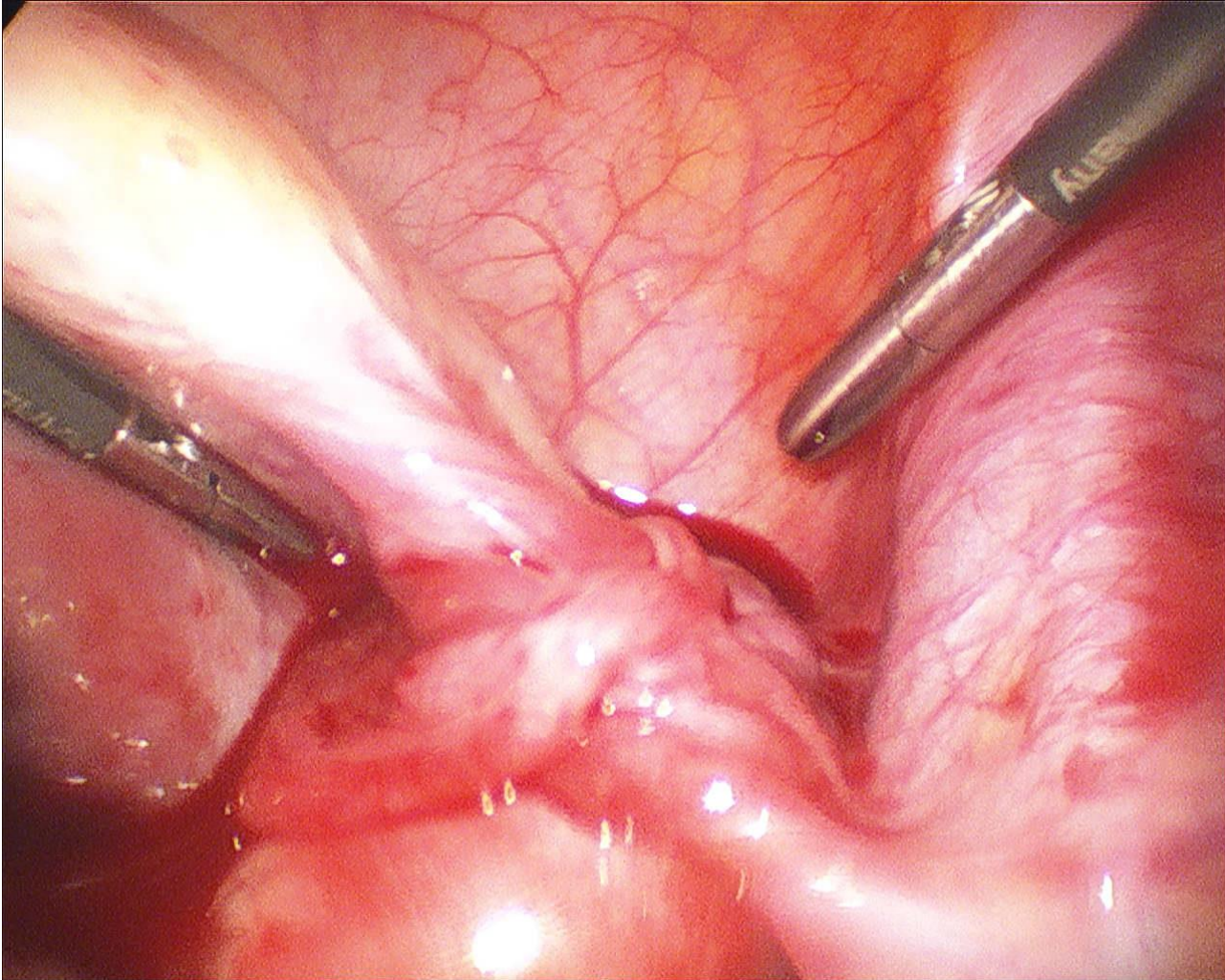
- Torsion de kyste ovarien
- Rupture de kyste ovarien
- Grossesse extra utérine
- Nécrose de myome
- Accouchement de myome intra cavitaire
- Maladie inflammatoire pelvienne (PID)
- Grossesse extra utérine
- Cancer

Examens complémentaires?

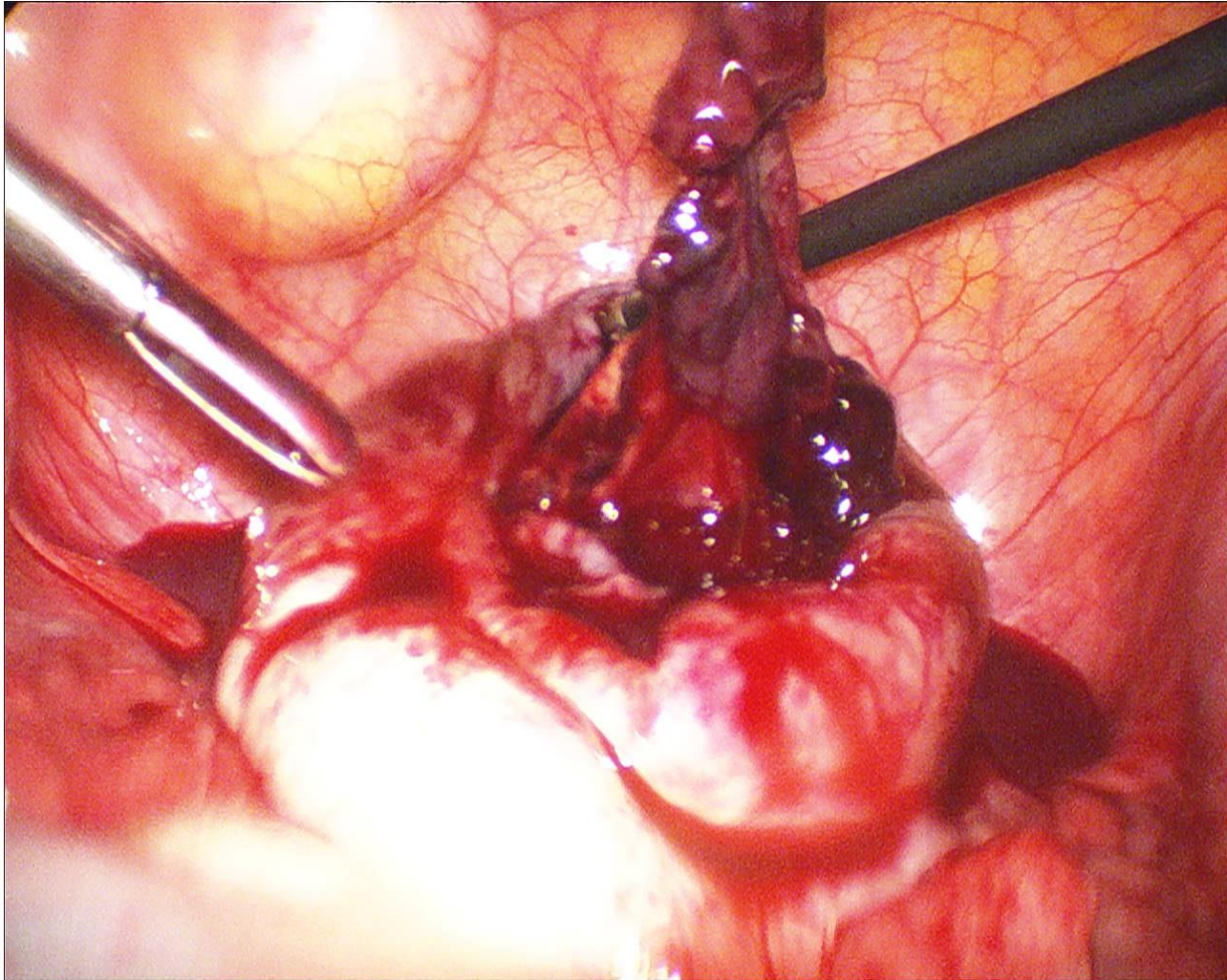
- Test de grossesse
 - Urinaire, sanguin
- FSS, CRP, groupe sanguin...
 - Év. Voie veineuse
- Examen urinaire
 - Bandelette, culture
- Ultrason



Torsion annexielle



Kystektomie

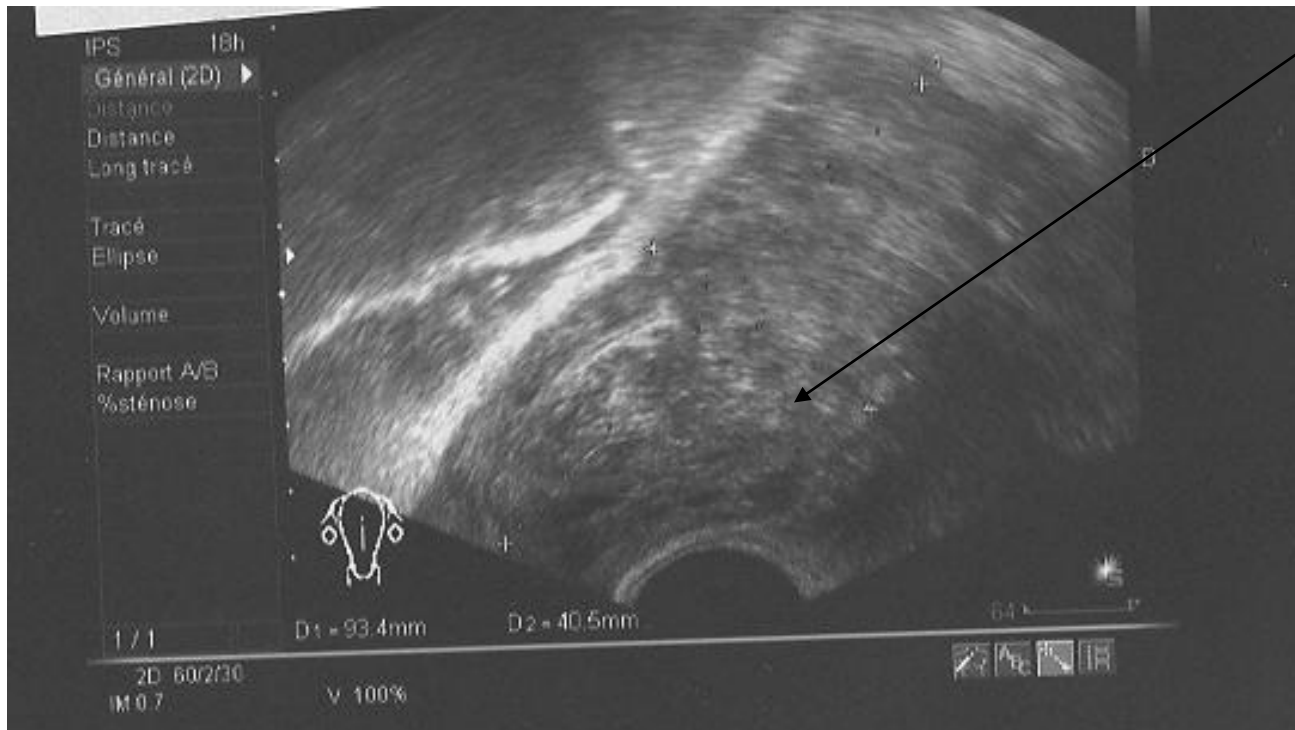


Examens complémentaires?

- Test de grossesse
 - Urinaire, sanguin
- FSS, CRP, groupe sanguin...
 - Év. Voie veineuse
- Examen urinaire
 - Bandelette, culture
- Ultrason

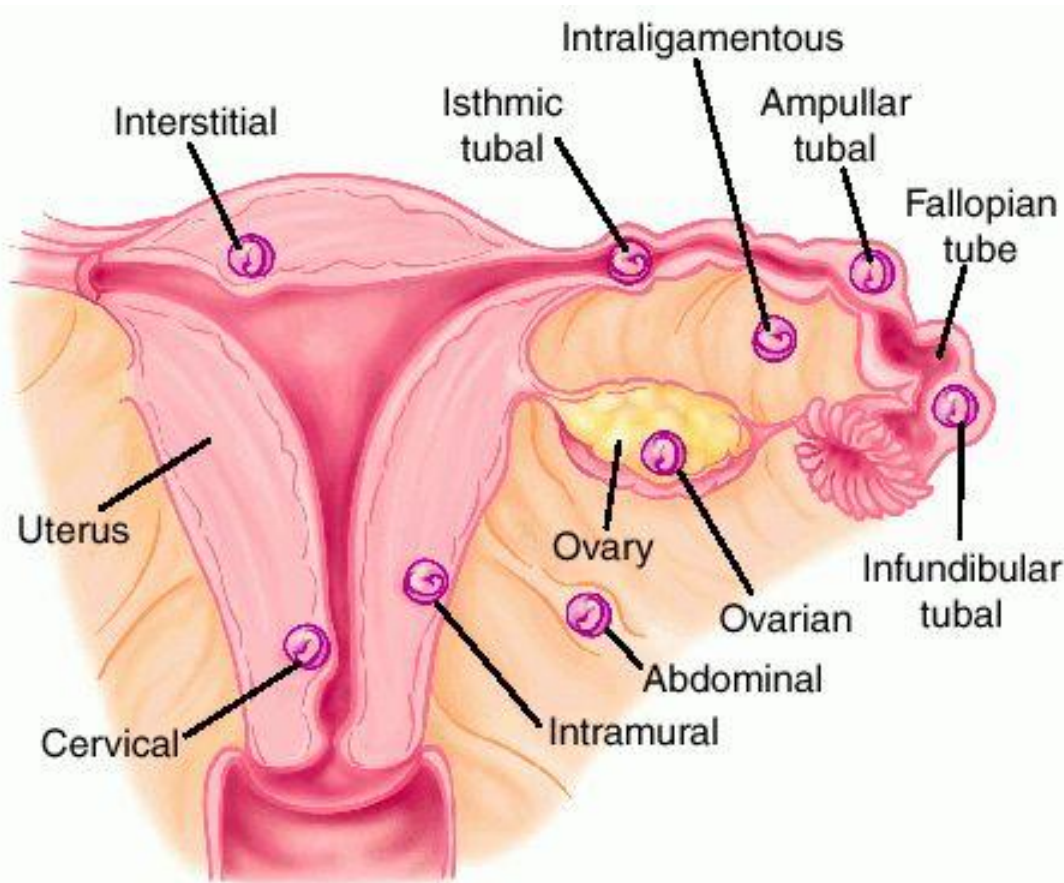
Echographie

Hématosalpinx



Diagnostic?

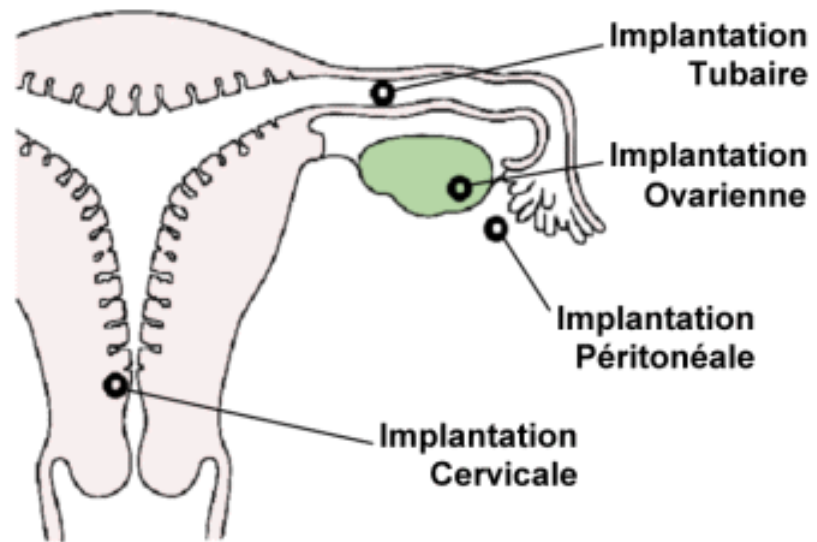
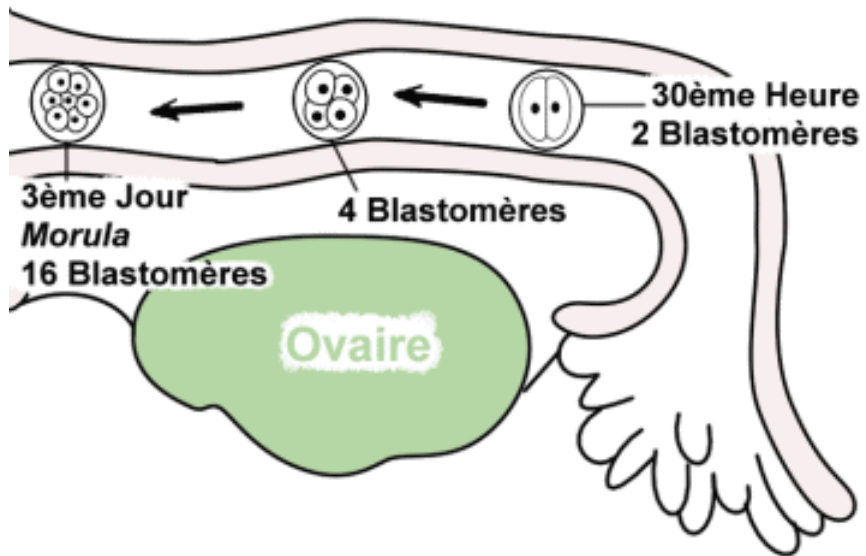
Grossesse extra-utérine



Ampullaire: 85-90%

Isthmique: 10-15%

Cornuale: rare



Evolution

- **Abortus tubaire**: la grossesse est expulsée dans la cavité péritonéale ou utérine
- **Rupture tubaire**: déchirure de la trompe avec hémorragie intra-abdominale

LA GEU EST UNE MALADIE LETALE!

Vignette clinique

- Patiente 3G0P de 35 ans avec s/p GEU D traitée par salpingectomie par laparoscopie en 2015, à 7 SA selon DDR du 09.09, arrivée en ambulance suite à malaise avec PC de 1-2min chez GT (avant la consultation), pas de traumatisme crânien. US abdo chez GT (faite sur patiente allongée au sol) : liquide libre, pas d'image de sac intra-utérin.
- Douleurs prédominantes en FIG à 4/10, pas d'antalgie reçu dans l'ambulance, hypoTA 90/60, puls 60/min, stable.
- Se plaint par ailleurs d'une sensation de dyspnée depuis 2 semaines sans douleurs thoraciques ni douleurs aux mollets, retour d'un voyage en Indonésie le 29.09.19
- BSH, pas d'allergie.

Facteurs de risque

- Facteurs tubaires:
 - ATCD PID
 - ATCD GEU
 - Chirurgie tubaire (échec stérilisation, PID, GEU)
- Pathologies pelviennes
 - Endométriose
 - Adhéhérences
- Autres:
 - Tabagisme
 - Traitements d'infertilité (FIV)
 - DIU
 - Pilule avec progestatif seul ou implant progestatif

Clinique

- Triade classique
 1. Douleurs pelviennes
 2. Métrorragies
 3. Aménorrhée

Toute douleur pelvienne chez une femme en âge de procréer doit faire évoquer et exclure le diagnostic de GEU

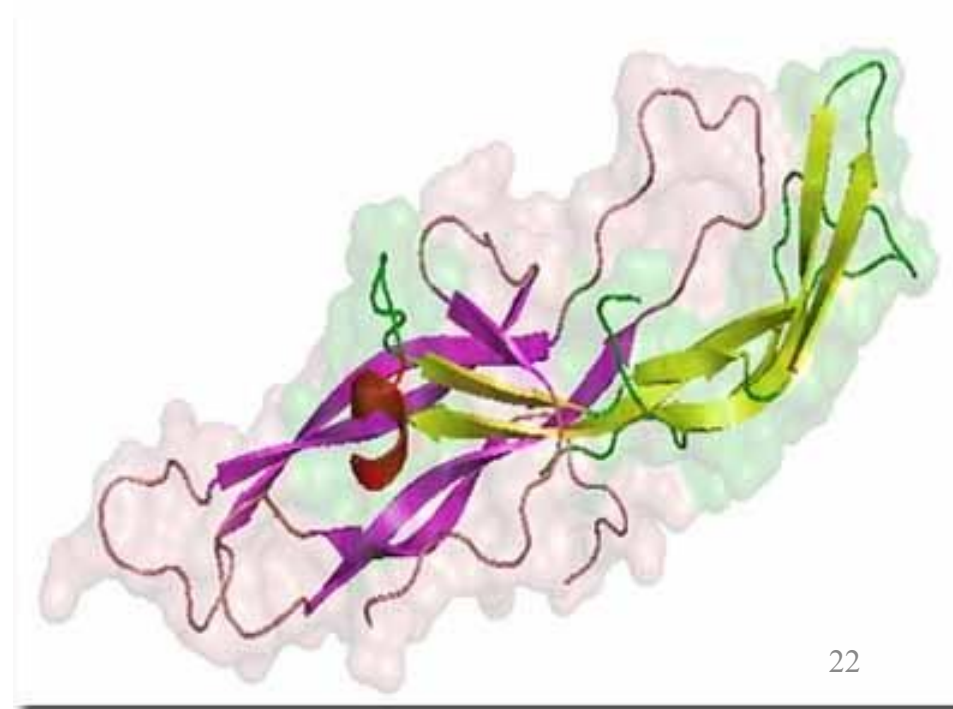
Diagnostic

- Poser le diagnostic de grossesse
 - TG urinaire: qualitatif (25-30 UI/L)
 - TG sanguin: dosage quantitatif de bêta-HCG
- Fréquence GEU: 1-2%
- Se demander si la grossesse est intra-utérine

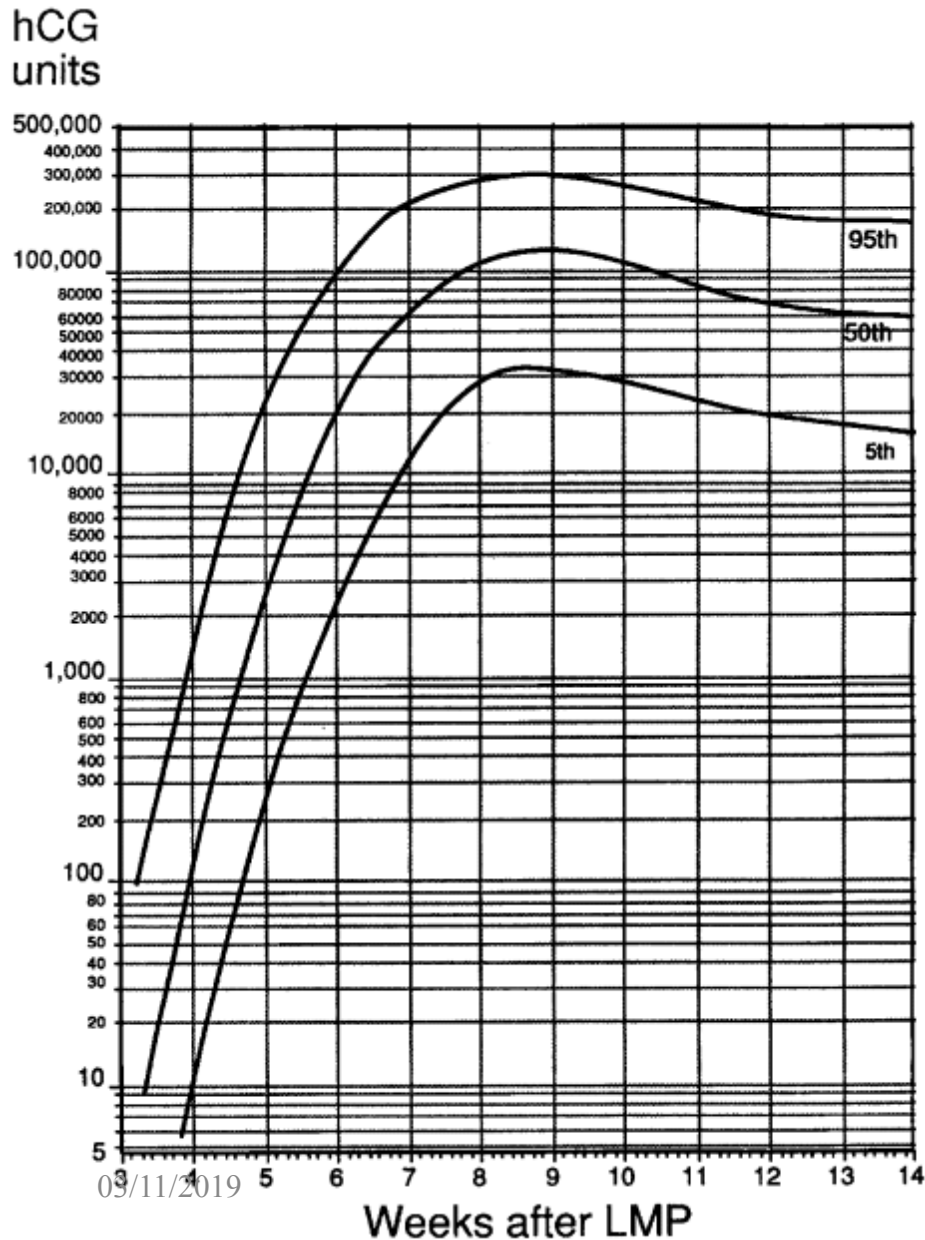


Béta-HCG

- Hormone gonadotrophine chorionique
 - 2 chaînes: α et β
- Sécrétée dès implantation de l'oeuf
- Sous-unité bêta est spécifique du trophoblaste



Sécrétion HCG

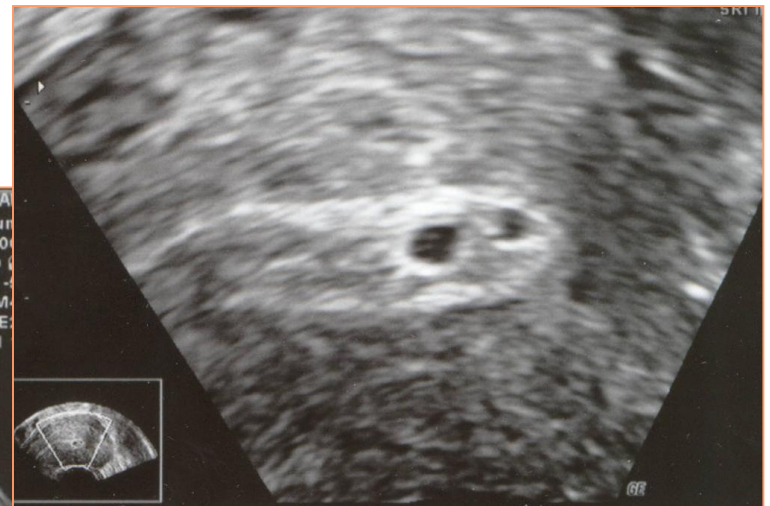


- Le taux de bêta HCG doit « doubler » toutes les 48 heures
- A partir d'un taux de env. 1000 UI/L, une grossesse doit être visible à l'échographie endovaginale

Echographie

- Recherche de sac gestationnel intra-utérin
- Recherche de masse para-utérine évocatrice
- Recherche d'épanchement du Douglas

Grossesse 4-5 SA

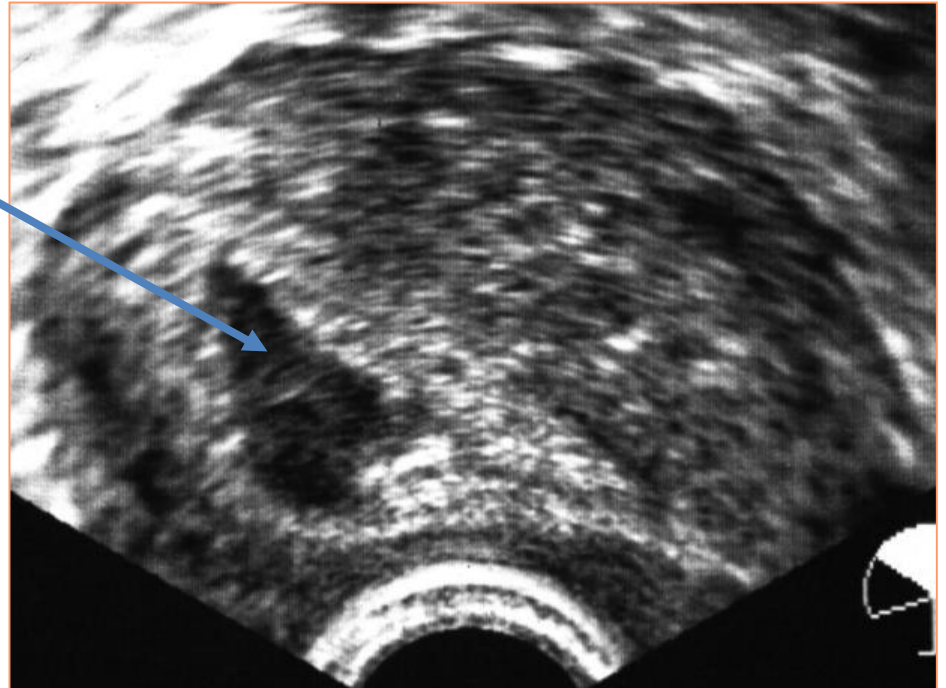


Grossesse 5-6 SA



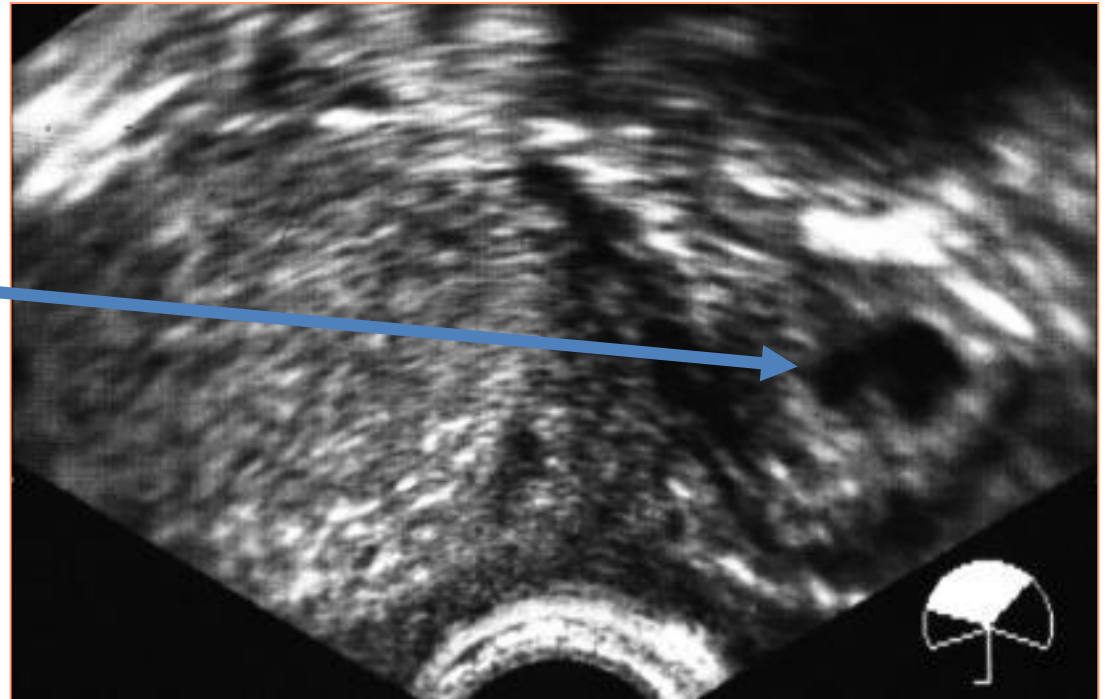
Pseudo-sac gestationnel

Pseudo-sac



Grossesse extra-utérine

Anneau tubaire



Traitement

- Médical
 - Méthotrexate
 - Surveillance serrée jusqu'à guérison
- Chirurgical
 - Laparoscopie
 - Conservateur: salpingotomie
 - Radicale: salpingectomie
 - Laparotomie: en cas d'hémopéritoine massif

Le Méthotrexate

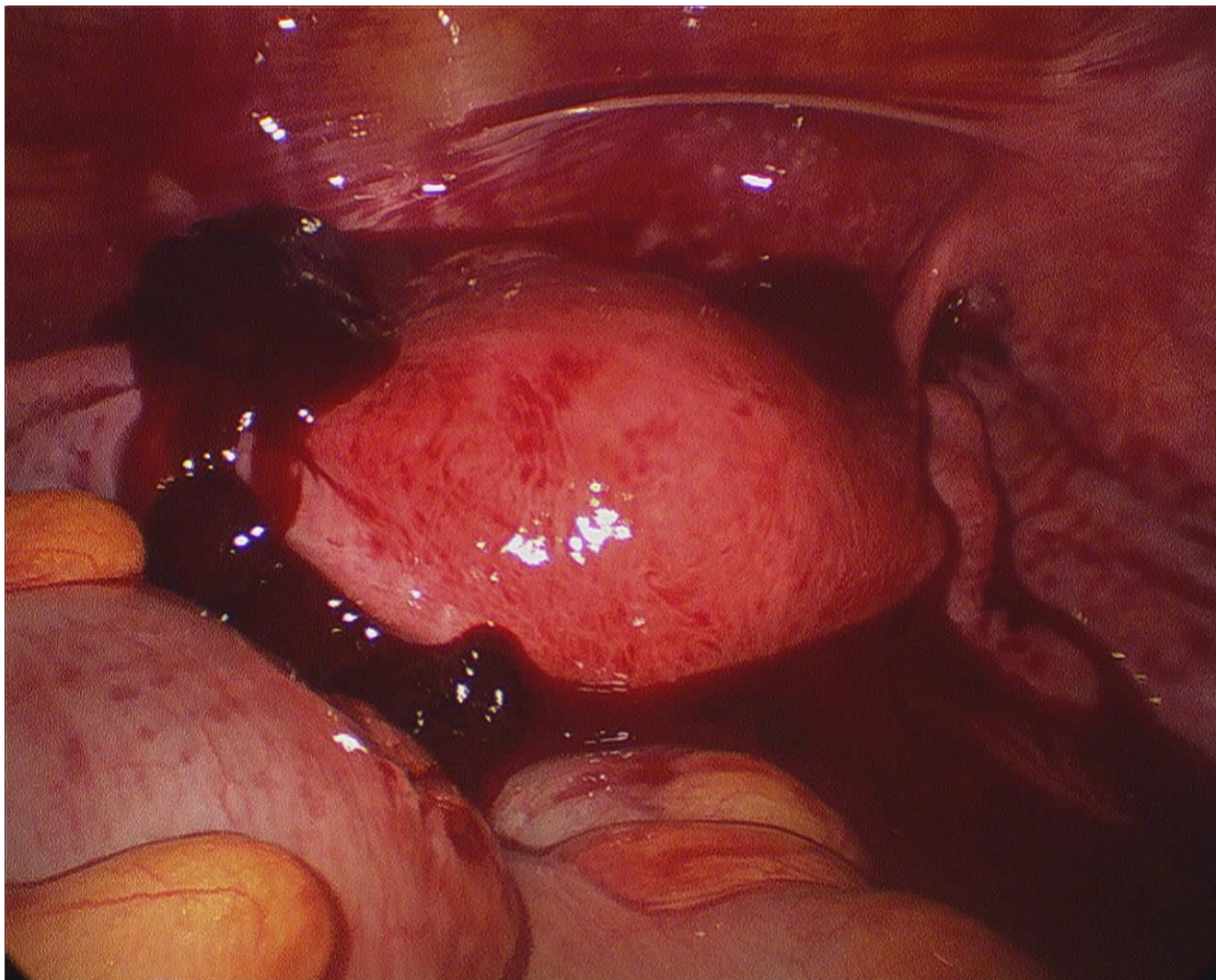
- Antagoniste de l'acide folique, il bloque le transport actif, membranaire, saturable des folates et est par conséquent, surtout actif sur les cellules en phase S.
- Les cellules syncytiotrophoblastiques ont une activité métabolique intense, la prolifération est bloquée, les signaux hormonaux diminuent, entraînant une involution de la grossesse.
- Les effets secondaires sont: stomatites, colites, alopécie, cytopénies, perturbation des tests hépatiques et sont dose dépendants.

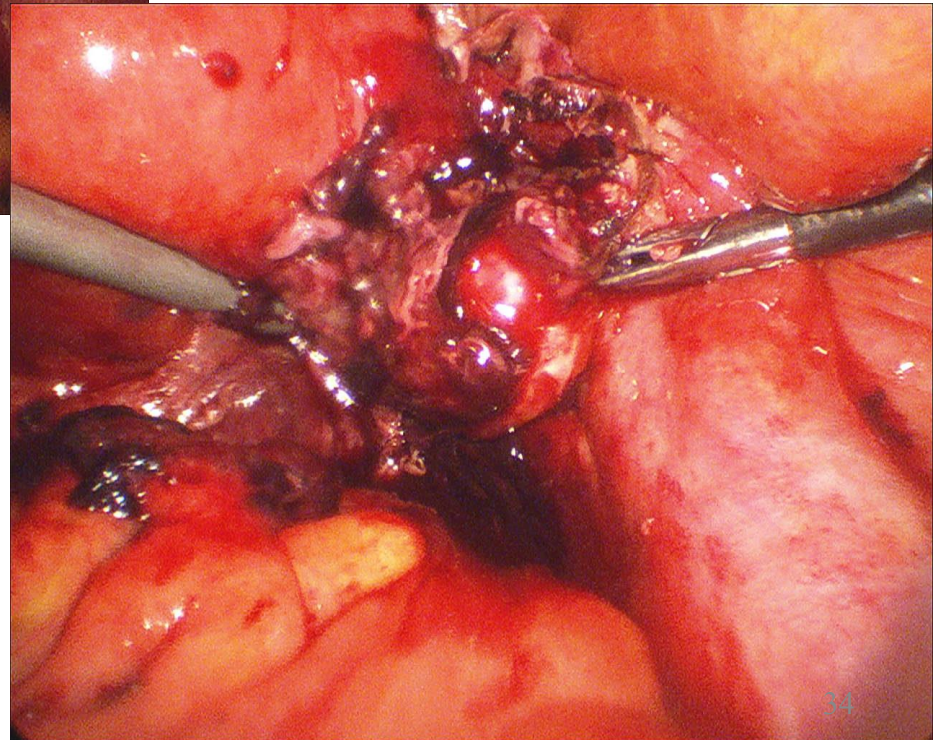
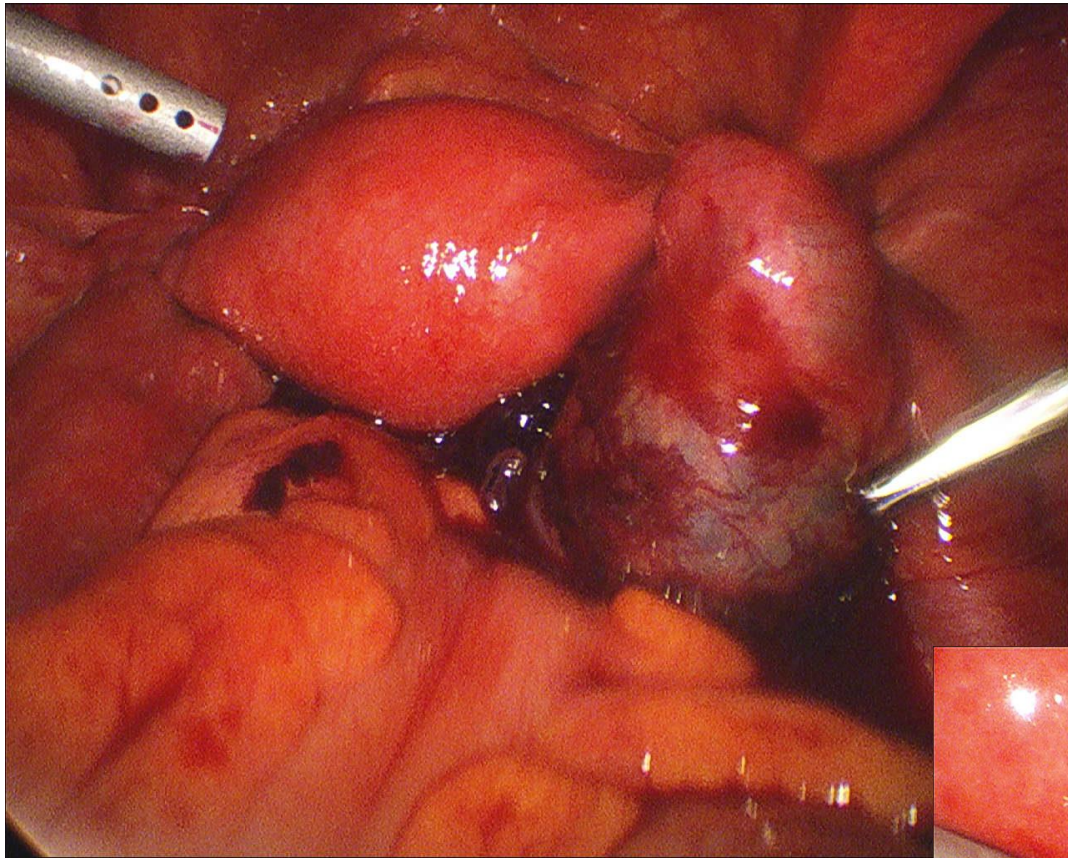
Contre-indications au traitement par Méthotrexate

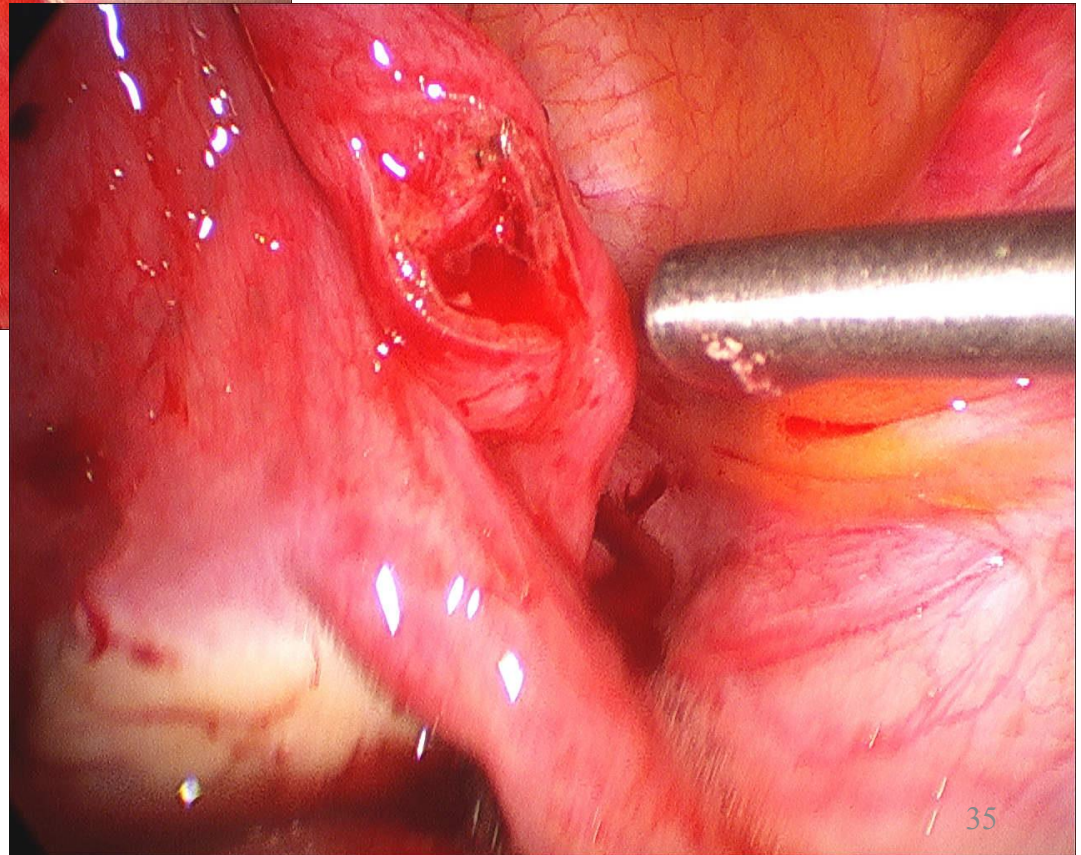
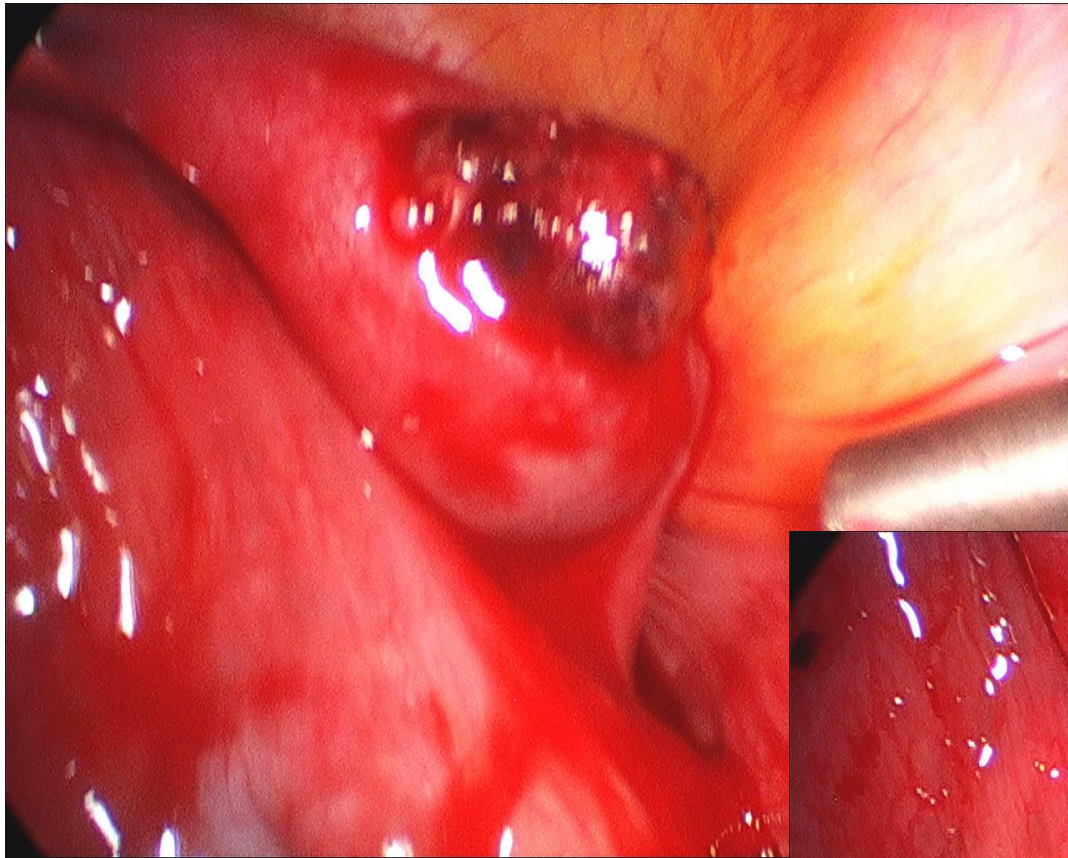
- Instabilité hémodynamique
- BHCG >10 000 UI/ml
- Hématosalpinx > 4 cm
- Eloignement géographique, seule à domicile, patiente peu collaborante

Laparoscopie

- Salpingectomie
 - Si trompe controlatérale est saine: (presque) pas de diminution de la fertilité
 - Si saignement non maîtrisable
- Salpingotomie: récidence GEU 15%
 - Si l'état de la trompe le permet
 - Si la localisation le permet







Douleurs pelviennes chroniques

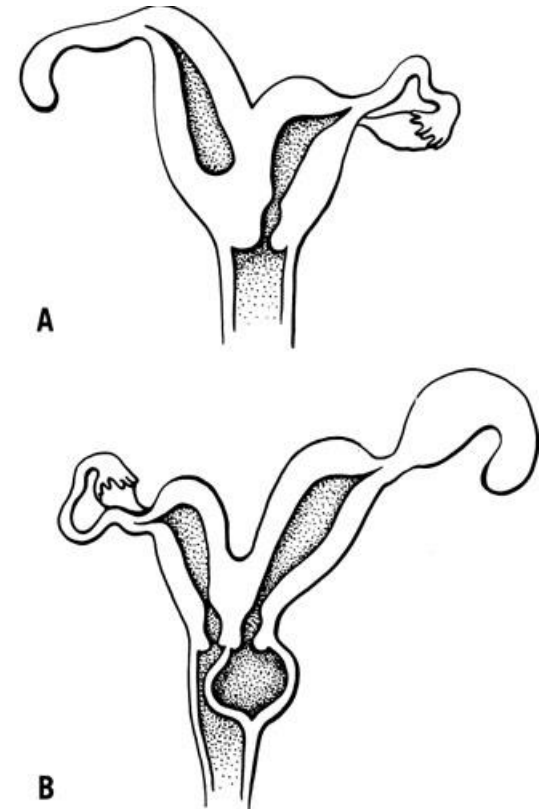
- Définition:

Douleur de siège pelvien, durant depuis plus de trois mois et assez sévère pour entraîner une gêne fonctionnelle et une demande de traitement médical ou chirurgical.

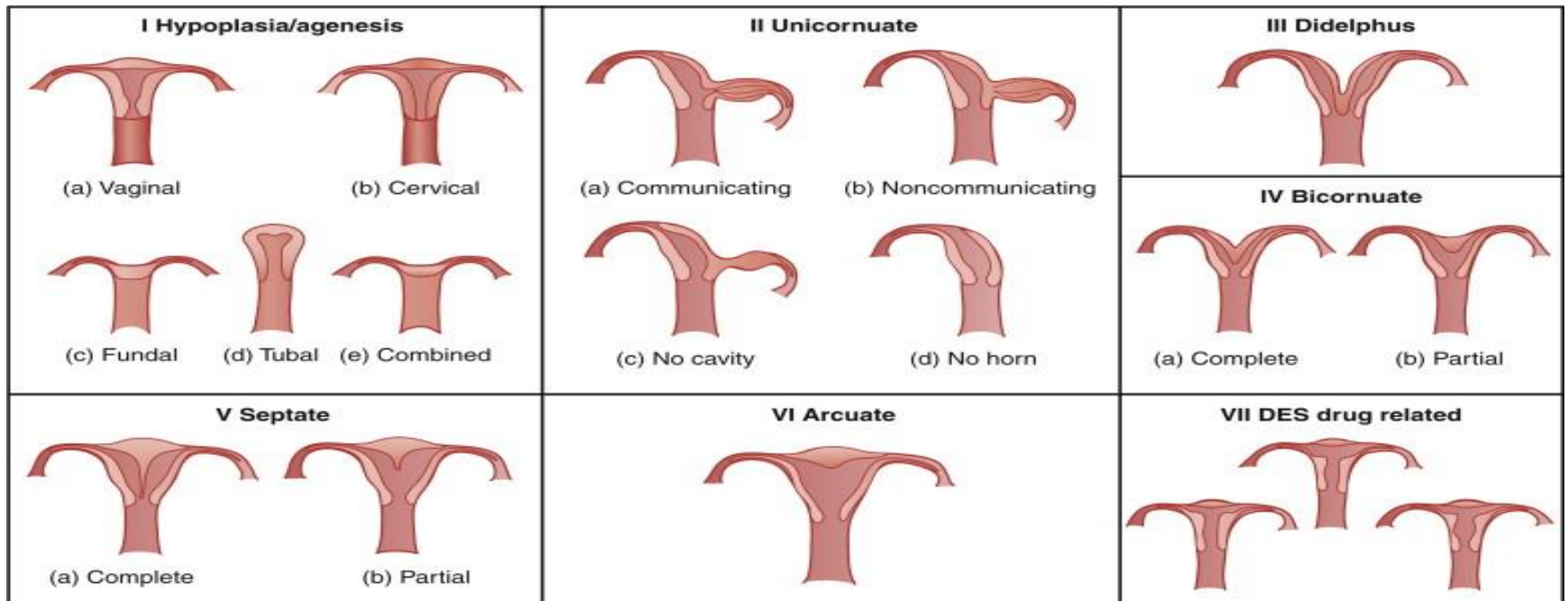
Vignette clinique

AA: patiente de 17 ans en BSH, consulte un gynécologue pour la première fois pour des douleurs importantes lors des règles depuis la ménarche.

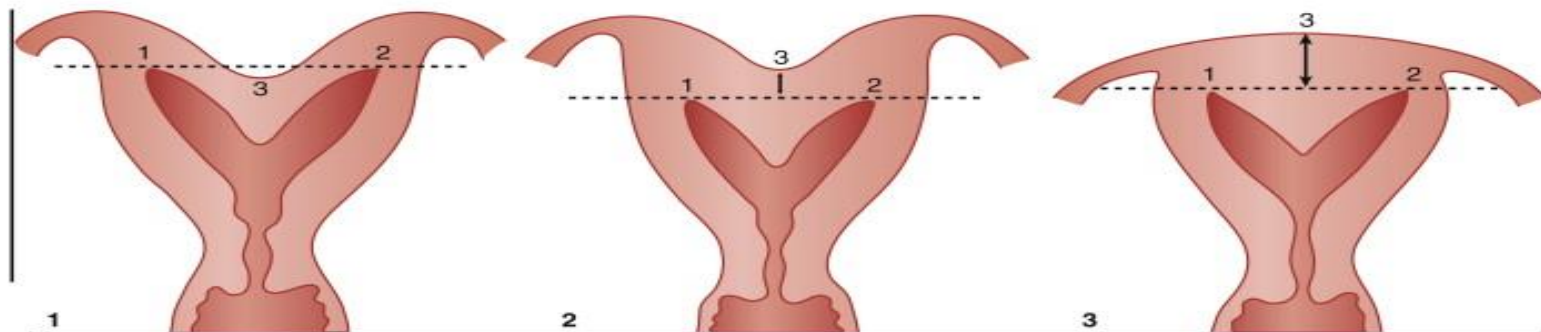
Status: au speculum, présence d'une masse de 6 cm, rénitente et douloureuse à la palpation.



Malformations utérines



A



B

Douleurs cycliques

- Syndrome prémenstruel
- Dysménorrhée
 - Primaire
 - Secondaire
- « Mittelschmerz »
- Endométriose, Adénomyose

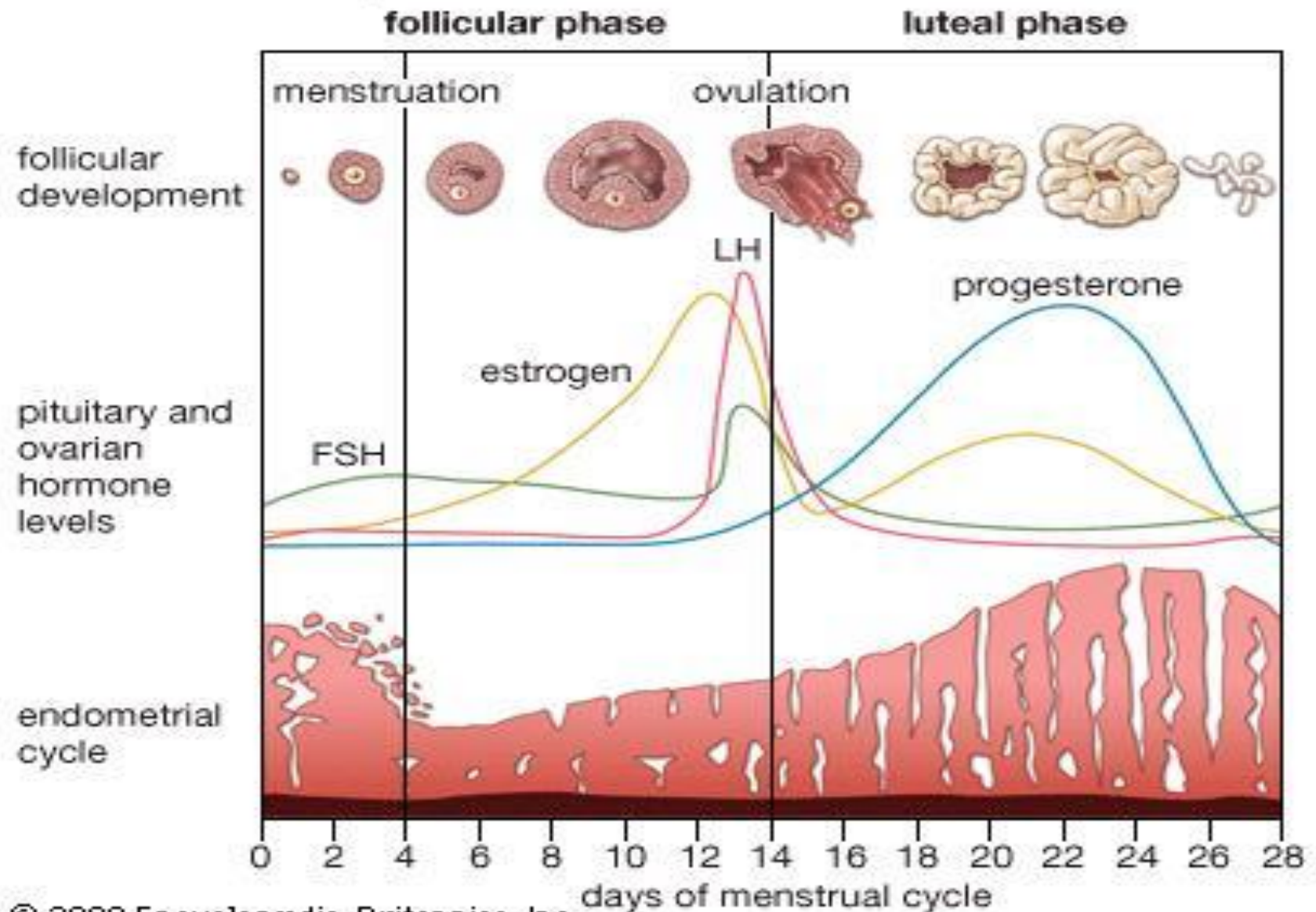
Douleurs pelviennes chroniques

- Écoute de la patiente
- Analyse précise de la symptomatologie associée
- Examen clinique

Douleurs pelviennes chroniques

- Douleurs **cycliques**
 - Syndrome prémenstruel, dysménorrhée
 - Endométriose, adénomyose
 - « Mittelschmerz »
- Douleurs **non cycliques**
 - Infections ou séquelle d'infection
 - Tumeurs: bénignes (ovaires, myomes), malignes
 - Troubles de la statique: prolapsus
- Causes extra-génitales
 - Digestives: par ex. colon irritable
 - Urinaires: par ex. cystite interstitielle
 - Musculo-squelettiques
 - Neurologiques

The menstrual cycle



© 2008 Encyclopædia Britannica, Inc.

Dysménorrhée

- Définition: douleurs liées aux règles
 - Primaire: sans substrat organique (augmentation de production endométriale de PG)
 - Secondaire: à une affection organique (p.ex: endométriose, malformation utérine)
- Symptôme fréquent:
 - 10-15% jeunes filles
 - 5-10% des jeunes femmes
 - 2-5% des jeunes mères



Dysménorrhée

- Expression variable, de légères crampes jusqu'à douleur invalidante nécessitant l'alitement
- Siège de la douleur pelvien avec irradiation dorsale, sacrée, vers le périnée, le vagin, la vessie et souvent tout le ventre
- +/- troubles digestifs: nausées, vomissements, diarrhée
- +/- céphalée, asthénie, lipothymie

Traitement

- Dysménorrhée **primaire**:
 - Exclure cause organique (malformation utérine)
 - Examen clinique, US, (év. IRM)
 - Expliquer!
 - AINS, pilule E/P (évt. en continu)
- Dysménorrhée **secondaire**
 - Recherche et traitement de la cause:
 - Adénomyose, endométriose, fibromes, DIU, prolapsus, sténose du col...

Syndrome prémenstruel (SPM)

- Symptômes psychologiques
 - Irritabilité
 - Dépression
 - Changement d'humeur
- Symptômes physiques
 - Tension mammaire
 - Gonflement généralisé
- Le diagnostic repose sur l'intensité des symptômes et sur le caractère cyclique

DAILY RECORD OF SEVERITY OF PROBLEMS

Please print and use as many sheets as you need for at least two FULL months of ratings. Name or Initials _____
Month/Year _____

Each evening note the degree to which you experienced each of the problems listed below. Put an "X" in the box which corresponds to the severity: 1 - not at all, 2 - minimal, 3 - mild, 4 - moderate, 5 - severe, 6 - extreme.

Enter day (Monday, "M"; Thursday, "T"; etc.) > _____
Note spotting by entering "S" > _____
Note menses by entering "M" > _____
Begin rating on correct calendar day > _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Felt depressed, sad, "down" or "blue", or felt hopeless, or felt worthless or guilty																															
2 Felt anxious, tense, "keyed up" or "on edge"																															
3 Had mood swings (i.e. suddenly feeling sad or tearful) or was sensitive to rejection or feelings were easily hurt																															
4 Felt angry or irritable																															
5 Had less interest in usual activities (work, school, friends, hobbies)																															
6 Had difficulty concentrating																															
7 Felt lethargic, tired or fatigued; or had lack of energy																															
8 Had increased appetite or overate; or had cravings for specific foods																															
9 Slept more, took naps, found it hard to get up when intended or had trouble getting to sleep or staying asleep																															
10 Felt overwhelmed or unable to cope; or felt out of control																															
11 Had breast tenderness, breast swelling, bloated sensation, weight gain, headache, joint or muscle pain, or other physical symptoms																															
At work, school, home or in daily routine, at least one of the problems noted above caused reduction of productivity or inefficiency																															
At least one of the problems noted above caused avoidance of or less participation in hobbies or social activities																															
At least one of the problems noted above interfered with relationships with others																															

Traitement du SPM

First line Exercise, cognitive behavioural therapy, vitamin B6
Combined new generation pill (cyclically or continuously)
Continuous or luteal phase (day 15–28) low dose SSRIs, e.g. citalopram/escitalopram 10 mg



Second line Estradiol patches (100 micrograms) + micronised progesterone (100 mg or 200 mg [day 17–28], orally *or* vaginally) or LNG-IUS 52 mg
Higher dose SSRIs continuously or luteal phase, e.g. citalopram/escitalopram 20–40 mg



Third line GnRH analogues + add-back HRT (continuous combined estrogen + progesterone [e.g. 50–100 micrograms estradiol patches *or* 2–4 doses of estradiol gel combined with micronised progesterone 100 mg/day] or tibolone 2.5 mg)



Fourth line Surgical treatment ± HRT

Vignette clinique

AA: Une patiente de 28 ans en BSH, sans contraception, avec désir de grossesse depuis 8 mois consulte son médecin traitant.

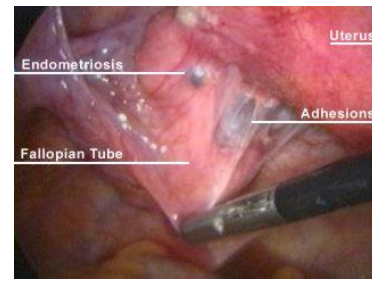
AP: pas d'intervention abdo.

Tabac: nihil, OH: occ

Status: col de NP sans lésion, présence de lésion bleutée dans le CdS vaginal postérieur. TV: induration du ligament utéro-sacré G



Endométriose



1. Présence de tissu endométrial (glandes et stroma) en dehors de la cavité utérine:

- Localisation les plus fréquentes:
 - Péritoine pelvien: Douglas, lig. utéro-sacrés
 - Organes pelviens (ovaires, trompes, etc.), septum recto-vaginal
- N'importe quel organe! (Cf. pneumothorax cataménial)

2. Maladie gynécologique fréquente chronique dépendante aux E2 associée avec:

1. Douleur
2. Infertilité

3. Femmes asymptomatiques (stérilisation laparoscopique):
prévalence de 3-43%

4. Femmes avec douleur et/ou infertilité: prévalence 20-90%

Physiopathologie endométriose

1. MENSTRUATION RETROGRADE de tissu endométrial dans la cavité pelvienne par les trompes
2. ATTACHEMENT du tissu endométrial à l'épithélium du péritoine
3. INVASION de l'épithélium en établissant des vaisseaux sanguins et en générant une réponse immune

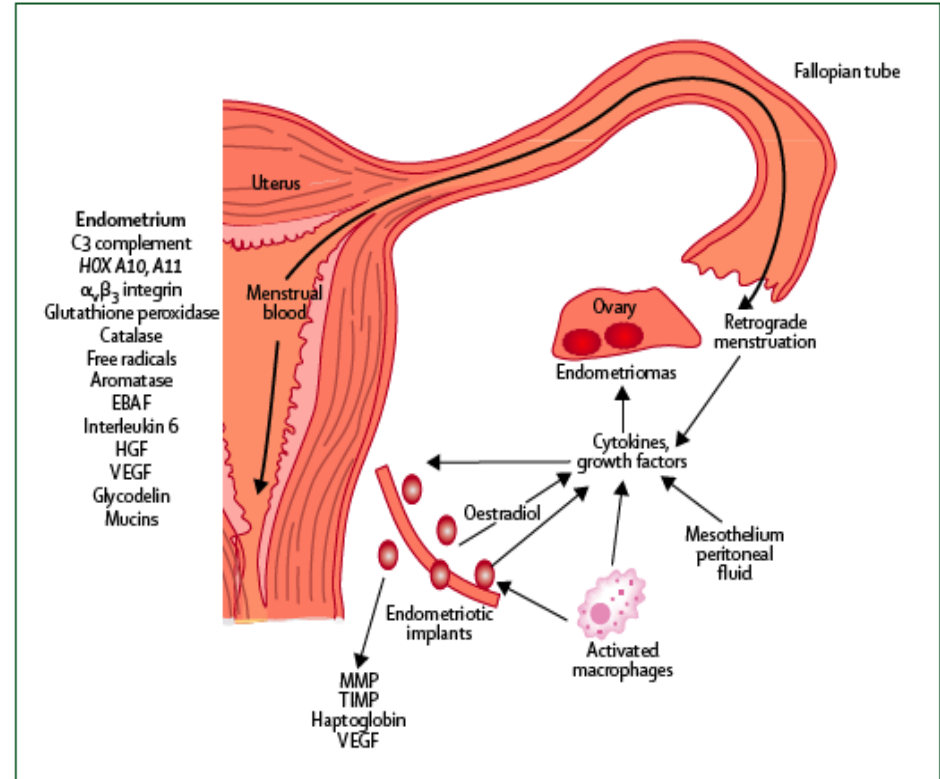


Figure: Schematic diagram of events occurring in the pelvis with retrograde menstruation and the cellular and biochemical principles involved in the pathogenesis of endometriosis

EBAF=endometrial-bleeding-associated factor; HGF=hepatocyte growth factor; VEGF=vascular endothelial growth factor; MMP=matrix metalloproteinase; TIMP=tissue inhibitor of metalloproteinase.

BACKGROUND de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques

Endométriose

- Pic d'incidence avant 30 ans
- Forte incidence familiale (7:1 chez parents du premier degré)
- 20-25% sont asymptomatiques
- Il n'existe pas de corrélation entre le stade et les douleurs de l'endométriose
- Certains symptômes sont liés à la localisation des lésions: rectorragies cycliques, hématurie, dysuria, dyspareunie

Symptômes

- Plaintes parfois non spécifiques
- Retard de diagnostic: 8.0-11.7 ans!
- Symptômes les plus fréquents:
 - Douleur pelvienne chronique, exacerbées durant les règles (ou l'ovulation)
 - Dysménorrhée sévère
 - Symptômes digestifs ou urinaires cycliques
 - Dyspareunie profonde
 - Fatigue chronique

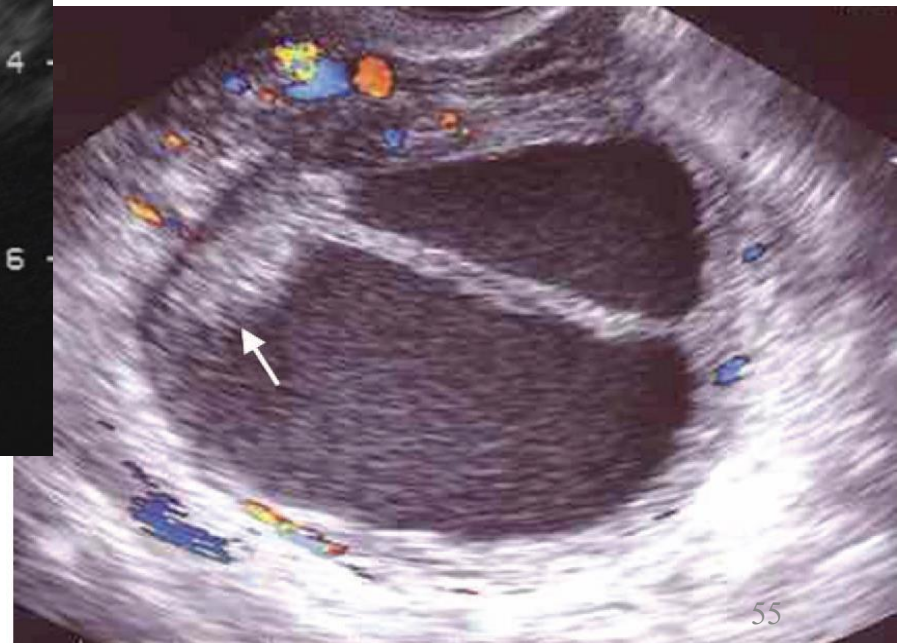
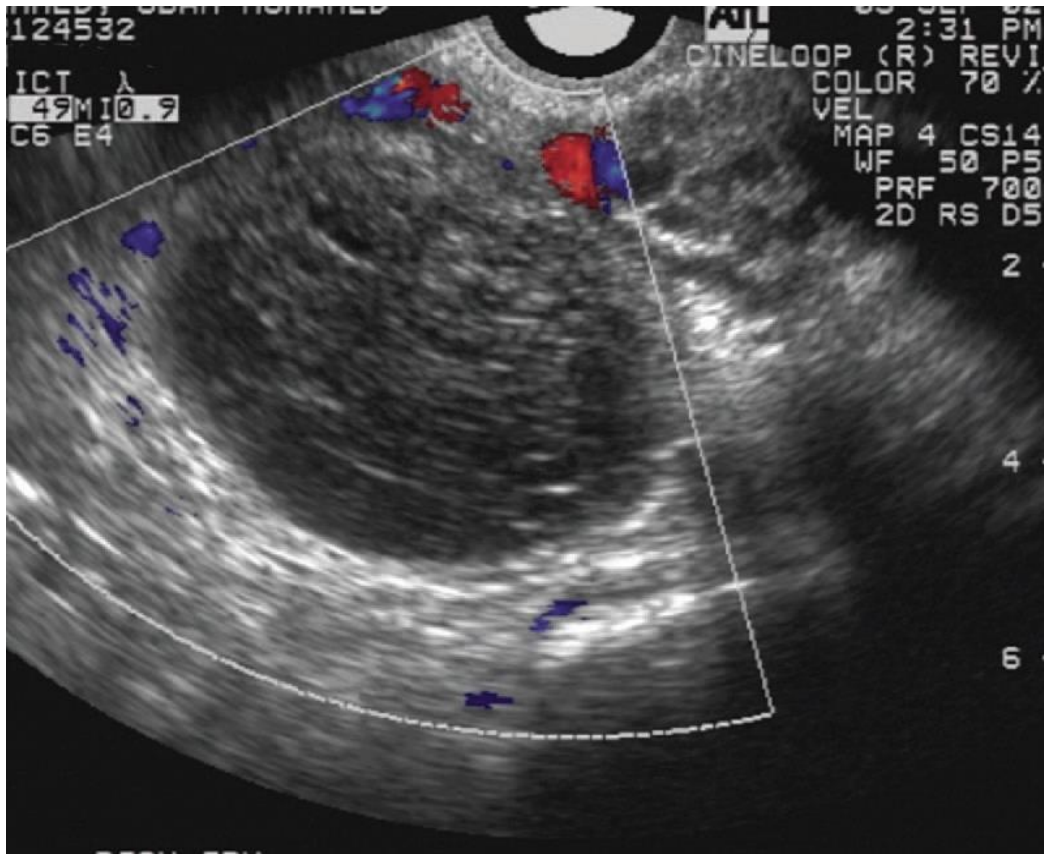
Signes cliniques

- Lorsqu'ils sont présents les signes cliniques sont:
 - Douleur à la palpation du cul de sac vaginal postérieur, cloison recto-vaginale, ligaments utéro-sacrés
 - Masse annexielle douloureuse
 - Utérus rétrofléchi, peu mobile

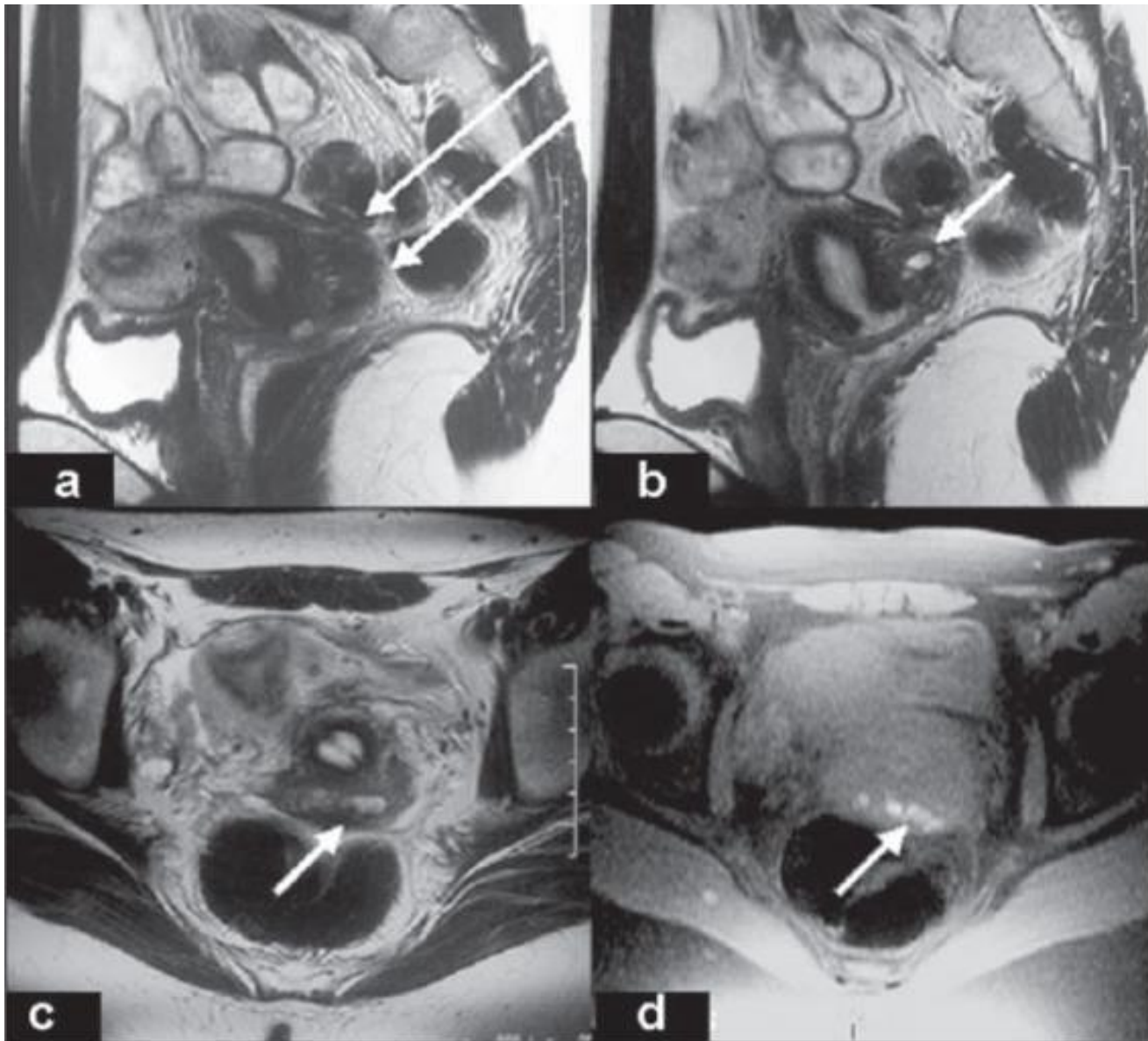
Examens complémentaires

- Echographie transvaginale
- IRM (lésions profondes; septum rectovaginal, vessie, uretères, sigmoïde)
- Recto-sigmoïdoscopie
- CA-125: mauvaise sensibilité et spécificité

Echographie transvaginale



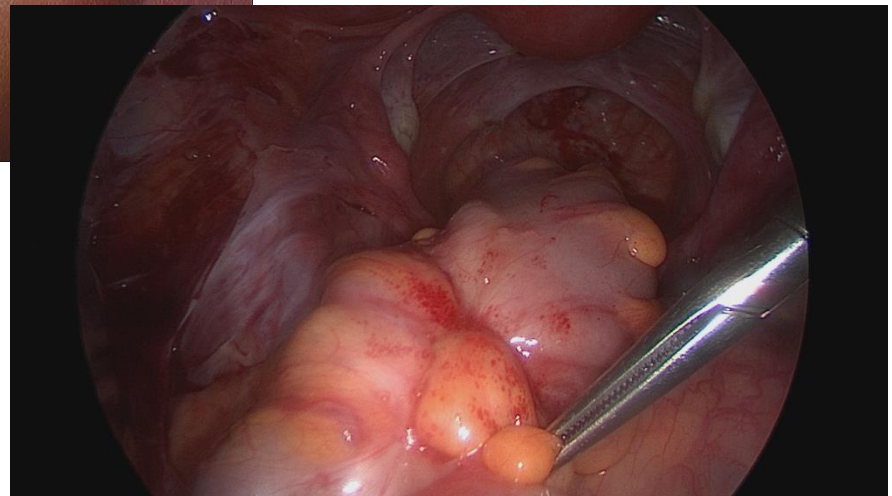
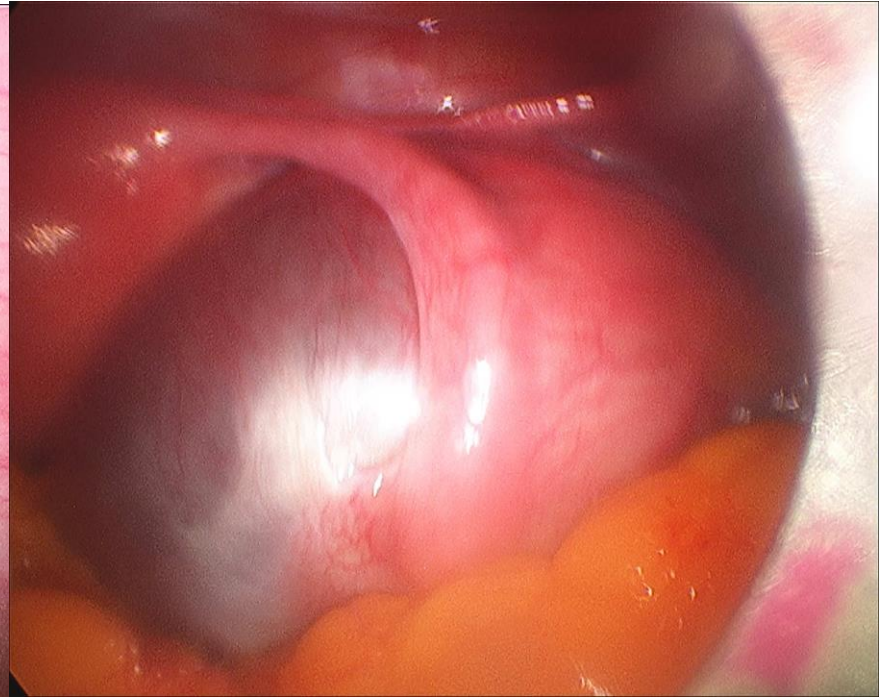
IRM



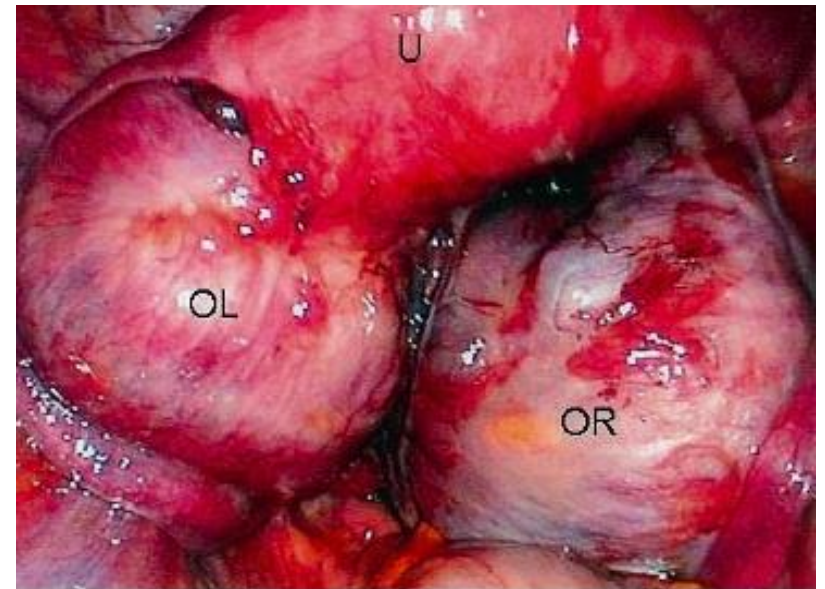
Diagnostic

Laparoscopie
avec
Biopsies des lésions

Laparoscopie



Laparoscopie



Scoring des lésions

- Classification de l'American Fertility Society:
 - Stage I (Minimal): 1-5
 - Stage II (Mild): 6-15
 - Stage III (Moderate): 16-40
 - Stage IV (Severe): >40
- Operator-dépendant



**THE AMERICAN FERTILITY SOCIETY
REVISED CLASSIFICATION OF ENDOMETRIOSIS**

Patient's Name _____ Date _____

Stage I (Minimal) - 1-5 Laparoscopy _____ Laparotomy _____ Photography _____
 Stage II (Mild) - 6-15 Recommended Treatment _____
 Stage III (Moderate) - 16-40 Prognosis _____
 Stage IV (Severe) - >40
 Total _____

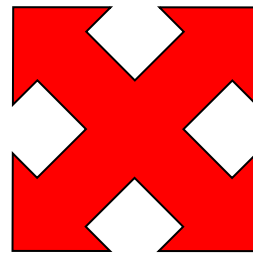
PERITONEUM	ENDOMETRIOSIS	< 1cm	1-3cm	> 3cm
	Superficial	1	2	4
	Deep	2	4	6
OVARY	R Superficial	1	2	4
	Deep	4	16	20
	L Superficial	1	2	4
	Deep	4	16	20
POSTERIOR CULDESAC OBSTRUCTION		Partial 4	Complete 40	
OVARY	ADHESIONS	< 1/3 Enclosure	1/3-2/3 Enclosure	> 2/3 Enclosure
	R Filmy	1	2	4
	Dense	4	8	16
	L Filmy	1	2	4
	Dense	4	8	16
	R Filmy	1	2	4
	Dense	4*	8*	16
	L Filmy	1	2	4
TUBE				
	Dense	4*	8*	16

*If the fimbriated end of the fallopian tube is completely enclosed, change the point assignment to 16.

Traitement

2 problèmes:

1. Douleur
2. Infertilité



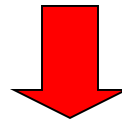
2 options:

1. Médical
2. Chirurgical

Endométriose $\neq$ Cancer

+

Mauvaise corrélation entre la sévérité des lésions et les symptômes



Traiter les symptômes mais pas les lésions *per se*

Choix du traitement

- Dépend de plusieurs facteurs
 - Age
 - Désir de grossesse
 - Douleur
 - Présence de lésions profondes
 - Réponse aux traitements précédents

Décision individuelle

Traitement médical

1. Le traitement médical est indiqué contre les douleurs mais pas pour l'infertilité
2. Le traitement médical ne guérit pas l'endométriose
-> le traitement doit être administré jusqu'au moment où une grossesse est désirée
3. Les différentes options ont une efficacité similaire
-> le choix doit être basé sur le profil le plus favorable en terme de sûreté, tolérabilité et coût

GnRH $\approx$ COC $\approx$ Progestatifs

Traitement médical

- Anti-douleurs
 - AINS, opioïdes (Tramal[®])
- Pilule oestro-progestative
 - Séquentiel ou continu
- Minipilule progestative (Cerazette[®])
- Dienogest (Visanne[®])
- Agonistes GnRH
- Stérilet au Levonorgestrel (Mirena[®])

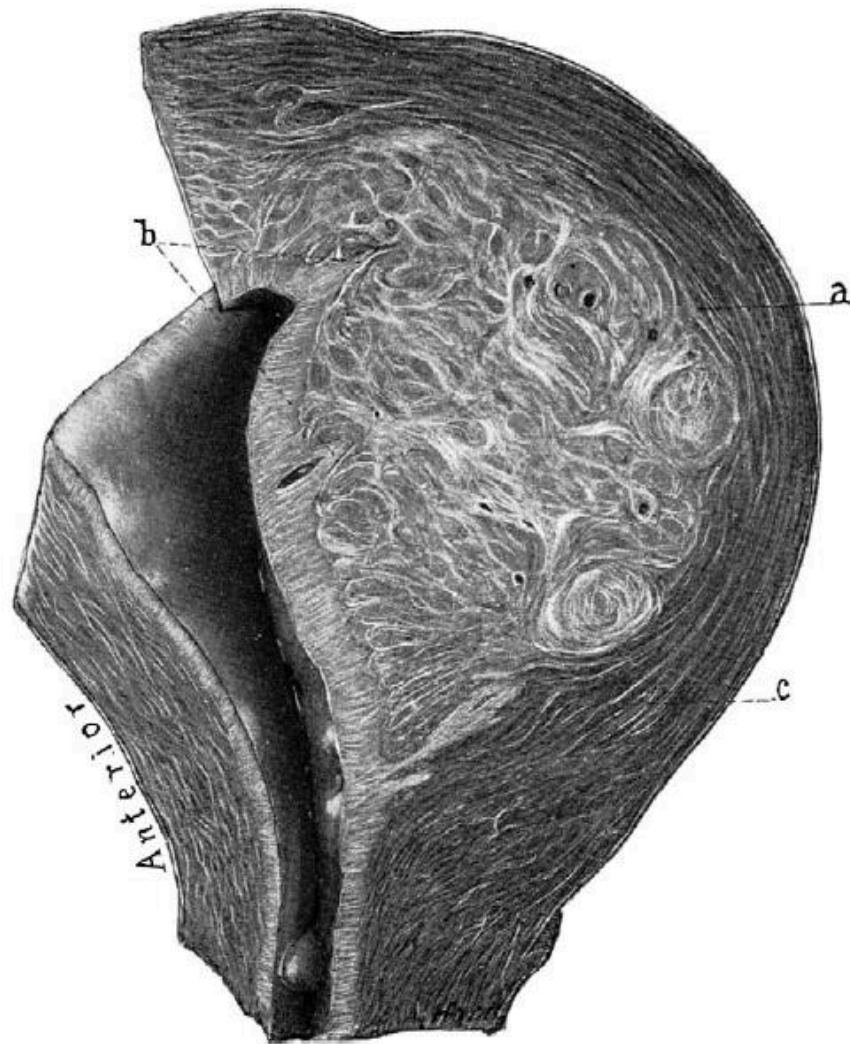
Traitement chirurgical

- L'excision chirurgicale des lésions sévères permet de diminuer les douleurs
- Indiqué en cas de:
 - Sténoses intestinale ou urétérale
 - Masse annexielle, surtout si d'origine incertaine
- Endométriose recto-vaginale, vésicale
- Possible amélioration de la fertilité
- CAVE! Multiple chirurgies et risque de diminution de la réserve ovarienne

Endométriose et infertilité

- Deux problèmes causés par l'endométriose:
 1. Toxicité « chimique »
 2. Modifications anatomiques
- Plusieurs études suggèrent un effet potentiellement délétère de l'endométriose sur les taux de grossesse:
 - Fluide péritonéal toxique pour le sperme et l'embryon
 - Endomètre eutopique anormal -> échec d'implantation
- Recours fréquent à la FIV (fécondation in vitro)

Adénomyose



From Cullen (1908, Adenomyoma of the Uterus,
Philadelphia & London: W.B. Saunders)⁶⁷

Adénomyose

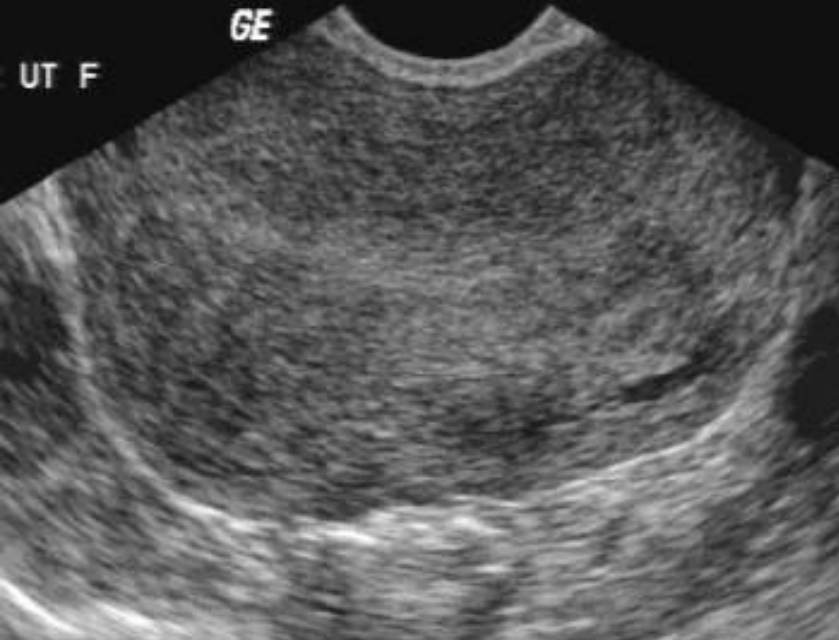
1972: Bird et al. nous apportent la définition actuelle de l'adénomyose:

‘Benign invasion of endometrium into the myometrium, producing a diffusely enlarged uterus which microscopically exhibits ectopic, non-neoplastic, endometrial glands and stroma surrounded by the hypertrophic and hyperplastic myometrium’

Am J Obstet Gynecol. 1972 Mar;112(5):583-93

Adénomyose

- Age:
 - 4^{ème}-5^{ème} décade
 - Egalement présent chez les adolescentes
- Asymptomatique:
 - Dans une série, 35% des patientes avec adénomyose diagnostiquée sur la pièce d'hystérectomie étaient asymptomatiques
- Ménorragies:
 - Corrélation avec le degré d'invasion
- Dysménorrhées:
 - Corrélation avec le degré d'invasion
- Utérus agrandi et sensible
 - Surtout si associé à la présence de myome



Ultrasound image of adenomyosis.

